

Le Psicosi — Schema

Salute Mentale · Sessione 09

Psicosi: quadro generale

- **Psicosi** → rapporto radicalmente alterato con la realtà
 - **Due destrutturazioni** (**Jervis**): realtà esterna + identità interna
 - **Divisione classica**: organiche vs. funzionali
-

Psicosi organiche vs. funzionali

	Organiche	Funzionali
Causa	Biologica nota	Multifattoriale (bio + psico + sociale)
Esempi	Demenze, epilessia, sostanze	Schizofrenia, psicosi maniaco-depressiva
Io–qui–adesso	Struttura crollata: <i>non sa</i> dove/chi/quando è	Struttura intatta ma dissociata: <i>sa ma non si sente</i>

Psicosi organiche

Demenze

- **Processo** → indebolimento progressivo irreversibile di intelletto, affettività, volontà
- **Alzheimer** → degenerativa, identità si dissolve progressivamente
- **Demenza senile** → da invecchiamento e atrofia cerebrale
- **Demenze acquisite** → da sostanze (alcol) o agenti patogeni (sifilide)

Epilessia

- **Definizione** → scarica neuronale abnorme; "attacco a sorpresa" (greco)
- **Crisi generalizzate:**
 - *Grande male* → tonica (contrazione) → clonica (convulsioni) → risolutiva (sonno)
 - *Piccolo male* → assenza di pochi secondi, senza convulsioni, senza consapevolezza
- **Crisi parziali (focali)** → solo parte del cervello; manifestazione variabile (allucinazioni uditive, movimenti, parestesie)
- ⚠ **Piccolo male può sembrare distrazione in classe/foyer**

Psicosi da sostanze

- **Meccanismo** → agiscono sul sistema mesolimbico (dopamina) → sintomi psicotici per uso o astinenza
 - **Delirium tremens** → psicosi alcolica acuta da astinenza (tremore, allucinazioni, crisi)
 - ⚠ **Chi beve molto non può smettere bruscamente senza supervisione medica**
 - **Sindrome di Korsakov** → psicosi alcolica cronica → **amnesia anterograda**
 - **Cannabis indoor** → THC alto → **rischio psicotico (specie in cervelli in sviluppo)**
-

Sintomatologia comune a tutte le psicosi

- **Sintomi positivi** → delirio + allucinazioni (producono qualcosa che prima non c'era)
 - **Sintomi negativi** → apatia, abulia, ritiro sociale, appiattimento affettivo
 - **Disorganizzazione cognitiva** → pensiero frammentato, visibile nel linguaggio
-

Schizofrenia

- **Termine** → **Bleuler (1911)**: *schizein* (scissione) + *phren* (mente)
 - **Definizione clinica** → incapacità di tenere insieme le funzioni mentali
 - **Metafora** → **orchestra senza direttore: i musicisti ci sono, ma il risultato è rumore**
 - **DSM-5** → anomalie in 5 ambiti: deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, comportamento motorio anomalo, sintomi negativi
-

Sindrome fondamentale della schizofrenia

1. Dissociazione

Ambito intellettuale (disturbi formali del pensiero): - **Disorganizzazione**

→ pensiero frammentato, caotico; neologismi; ecolalia - **Impoverimento** → discorso povero, lento, evasivo (valutare vs. normalità personale precedente) -

Concretismo → incapacità di accedere al simbolico, ancorato al concreto -

Prolissità → discorso lungo, senza filtri, oscuro e poco concludente -

Tangenzialità → risposta "di traverso," sfiora il tema senza rispondere -

Deragliamento → salto improvviso da un tema all'altro, senza continuità logica

Ambito affettivo: - **Appiattimento** → reattività emotiva ridotta (**non assente** —

Bleuler: "*in nessun caso del tutto spenta*") - **Discordanza** → emozione

incongruente con la situazione (es. ridere di un lutto) - **Ambivalenza** → emozioni opposte copresenti nello stesso momento

Ambito psicomotorio: - **Riduzione** → ritiro, rallentamento (la più frequente) -

Aumento → agitazione psicomotoria; **crisi pantoclastica** (comportamento distruttivo senza finalità) - **Qualitativa** → **manierismi** (comportamenti esasperati e teatrali), stereotipie

2. Autismo

- **Definizione** → **perdita del contatto vitale con la realtà; ritiro nel mondo interno**

- **Oggi** → corrisponde ai sintomi negativi (ritiro, apatia, linguaggio non relazionale)

3. Delirio

- **Definizione** → convinzione falsa, incrollabile, palese agli altri
- **3 caratteristiche** (Sims, 2004): sostenuta con insolita convinzione / non riducibile alla logica / falsità palese
- **Contenuti frequenti**: persecuzione, avvelenamento, influenzamento, gelosia, grandiosità
- ⚠ **Il contenuto dipende dal background culturale del paziente**

4. Depersonalizzazione / Derealizzazione

- **Depersonalizzazione** → si percepisce come automa, si vede dall'esterno
- **Derealizzazione** → il mondo è estraneo, c'è una membrana tra sé e la realtà
- **Tempo** → congelato, cristallizzato, senza progettualità

5. Disturbi del comportamento

- **Suicidalità** → rischio 10-20x rispetto alla popolazione generale
 - ⚠ **Picco nel miglioramento, non nello scompenso**
- **Alimentazione** → deliri di avvelenamento → evitamento selettivo; pseudo-bulimia
- **Sessualità** → autoerotico, angoscia identitaria, voci allucinatorie

6. Allucinazioni

- **Tipo più frequente** → uditive
 - **Caratteristica** → indistinguibili da percezioni reali per il paziente
 - **Atteggiamento del paziente** → variabile: le nasconde, le apprezza, le teme
 - ⚠ **Voci perentorie con ordini pericolosi → massima vigilanza**
-

Angoscia psicotica

Disturbo	Tipo di angoscia	Rapporto con l'altro
Nevrosi	Castrazione (limite, impedimento)	Genitale (riconosce l'alterità)
Borderline	Abbandono	Anaclitico (appoggio vitale)
Schizofrenia	Frammentazione (andare a pezzi)	Fusionale (confine sé/altro labili)

Decorso della schizofrenia

Fase	Contenuto	Leggibilità
Premorbosa	Isolamento, ansia sociale, emotività fredda, resa scolastica critica	Solo retrospettiva
Prodromica	Stesse caratteristiche accentuate + pensiero strano, neologismi, ritiro progressivo	Retrospettiva + contemporanea
Stato (~20 anni)	Sintomi positivi manifesti (deliri, allucinazioni), scompenso psicotico	Clinica
Esiti	Remissione / ricadute / stato cronico	Lungo termine

Vulnerabilità premorbosa (Stanghellini & Ballerini, 2005)

- Difficoltà nelle relazioni interpersonali
- Disturbi socio-emozionali
- Disturbi del sé (pensiero, linguaggio, percezione)
- Disturbi delle funzioni neuropsicologiche
- Disturbi nel neurosviluppo

Tipo 1 vs. Tipo 2 (Crow, 1980)

	Tipo 1	Tipo 2
Sintomi predominanti	Positivi (deliri, allucinazioni)	Negativi (ritiro, apatia, deterioramento)
Decorso	Potenzialmente reversibile	Cronico con deterioramento progressivo
Risposta ai neurolettici	Buona	Ridotta

Fattori prognostici

Favorevoli → diagnosi precoce · intervento farmacologico immediato · andamento acuto iniziale · buon funzionamento premorbo · sesso femminile · esordio tardivo · rete sociale adeguata

Sfavorevoli → esordio precoce · familiarità · isolamento sociale · sintomi negativi dominanti · resistenza al trattamento

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Morel	Concetto di alienazione mentale	1860
Kraepelin	"Demenza precoce" — primo paradigma	Fine '800
Bleuler	Conia "schizofrenia"; "gruppo delle schizofrenie"	1911
Minkowski	Triade io–qui–adesso; psicosi organiche vs. funzionali	1951 / 2004
Jervis	Due destrutturazioni centrali nella psicosi	1984

Chi	Cosa	Quando
Pewzner	"Frattura radicale con la realtà"; definizione di psicosi	2002
Crow	Tipo 1 (positivi) / Tipo 2 (negativi)	1980
Stanghellini & Ballerini	Vulnerabilità premorbose, identikit del futuro paziente	2005
Mc Gorry & Jackson	Periodi prodromico e premorbo; intervento precoce	1999
Schultze-Lutter	Tre stadi di esito post-primario episodio	2009
Sims	Tre caratteristiche del delirio	2004
Casey & Kelly	Disturbi formali del pensiero	2013
Pancheri & Cassano	Manuale di psichiatria — riferimento principale	1999

Parole chiave

psicosi · organica · funzionale · io-qui-adesso · schizofrenia · dissociazione · delirio · allucinazione · depersonalizzazione · derealizzazione · sintomi positivi · sintomi negativi · disorganizzazione · autismo schizofrenico · angoscia di frammentazione · premorbo · prodromico · tipo 1 · tipo 2 · delirium tremens · Korsakov · epilessia · grande male · piccolo male · neologismi · ecolalia · tangenzialità · deragliamento · concretismo · appiattimento affettivo · discordanza · crisi pantoclastica · manierismi